内科含诊断 缺铁性贫血（含贫血概述）★★★（0~4 题）

铁代谢（2013）

2 价铁：吸收（十二指肠及空肠上段）、利用（合成 Hb 等）“xi、li”
3 价铁：运输（血清铁）、储存（铁蛋白和含铁血黄素）“yun、chu”

病因（2007、2009、2014、2020、2021）

- 铁丢失过多：慢性失血（如月经过多、痔疮、消化性溃疡、胃癌、ITP）、PNH 等
- 铁摄入不足或需求增加：婴幼儿、青少年、孕妇、哺乳期
- 铁吸收障碍：A 型胃炎、胃大部切除术后

临床表现（2010、2021）

- 一般贫血表现：乏力、头晕、心悸、苍白、左心扩大
- 组织缺铁表现：异食癖、舌乳头萎缩呈镜面舌、P-V 综合征（吞咽困难）、匙状 / 勺状 / 反甲、易感染

对比：牛肉舌 - 巨幼贫（2017）

诊断（2009、2014、2020、2022）

- 贮存铁耗尽（潜伏期）：血清铁蛋白↓（最敏感），骨髓小粒可染铁消失（最可靠），铁粒幼红细胞↓
- 红细胞内铁缺乏：有上述异常指标
  血清铁和转铁蛋白饱和度↓、总铁结合力↑、sTfR ↑（红细胞 Hb 合成）、游离原卟啉 FEP ↑、锌原卟啉 ZPP ↑
- 缺铁性贫血：有上述异常指标
  Hb ↓、MCV ＜ 80、MCHC ＜ 32%

Hb 男＜ 120、女＜ 110、孕妇＜ 100
＞ 90、60~90、30~59、＜ 30 →轻、中、重、极重度“三六九等”

治疗（2007）

首选有机铁（2011）、口服铁

补铁后最先升高：Ret（评价补铁是否有效，2021）
2 周后 Hb 开始升高、2 月左右恢复正常（2012）
Hb 正常后继续补铁 4~6 个月、待铁蛋白正常后停药“仓库”
“咏铁：网红十日高峰立、血红蛋白 2 周起、2 月正常别着急、半年才能停铁剂”

检查

骨髓

红系增生活跃、核老浆幼，骨髓细胞外铁（骨髓储存铁）和细胞内铁（铁粒幼红细胞）↓

血象

小细胞低色素性贫血
红细胞体积小、中央淡染区扩大

贫血分类（2014、2017、2020）

	MCV	MCHC	栗子
大细胞性“核”	>100		巨幼贫
小细胞低色素性	<80	<32%（320g/L）“三年二班跑 800 米”	缺铁贫、ITP、地贫、铁粒幼
正细胞性	80~100		多数溶贫（除地贫 / 遗传球）、再障、白血病、肾性贫血

RBC 正常或↓、WBC 多正常、Plt 多正常或↑（严重全血细胞可↓，2021）

可有全血细胞↓（2012）：再障、PNH、巨幼贫、MDS、Evans 综合征、SLE、明显脾亢
少数白血病、淋巴瘤骨髓浸润、骨髓瘤、放化疗

Ret 正常或↑

抓住小宝藏（2016、2019）

Ret 正常值 0.5%~1.5%，判断骨髓红系增生	
明显↑	溶血、巨幼贫原位溶血、急性失血
↓	再障（<1%、严重 <0.5%）、多数 MDS、白血病
正常或↑	缺铁贫、巨幼贫：补充原料后迅速↑ ITP、少数 MDS